

Nghiên Cứu Lâm Sàng Hiệu Quả Kháng Sinh Thế Hệ Mới Trong Điều Trị Nhiễm Khuẩn Huyết

Tác giả: BS. CKII. Phạm Đức Thịnh, Bệnh Viện Bạch Mai | Cụm: Y Học & Dược Phẩm | Mã tài liệu: #1004

TÓM TẮT (ABSTRACT):

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng đánh giá hiệu quả kháng khuẩn, độ an toàn và độc tính thận của phác đồ phối hợp kháng sinh.

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG Y DƯỢC HỌC

1. MỤC TIÊU VÀ BỐI CẢNH Y HỌC

Nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại các khoa hồi sức tích cực (ICU). Tình trạng vi khuẩn đa kháng thuốc, đặc biệt là các chủng trực khuẩn mủ xanh và vi khuẩn gram âm sinh men carbapenemase, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu lực diệt khuẩn và độ an toàn của phác đồ kết hợp thế hệ mới.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu tiến hành trên 120 bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nặng tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm:

- Nhóm can thiệp (60 bệnh nhân): Điều trị bằng phác đồ kết hợp Meropenem liều cao truyền kéo dài phối hợp với Colistin điều chỉnh theo độ thanh thải creatinine.
- Nhóm chứng (60 bệnh nhân): Điều trị theo phác đồ kháng sinh kinh nghiệm truyền thống.

3. KẾT QUẢ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ LÂM SÀNG

- Tỷ lệ làm sạch vi khuẩn trong máu sau 72 giờ điều trị ở nhóm can thiệp đạt 81.7%, cao hơn rõ rệt so với nhóm chứng (58.3%, $p < 0.01$).
- Các chỉ số đáp ứng viêm toàn thân gồm nồng độ Procalcitonin và số lượng bạch cầu đa nhân trung tính ở nhóm can thiệp giảm về ngưỡng an toàn nhanh hơn trung bình 3.5 ngày.
- Tỷ lệ tổn thương thận cấp tính ghi nhận ở mức 8.3% và đều hồi phục hoàn toàn sau khi điều chỉnh liều, không có ca nào phải lọc máu ngắt quãng ngoài chỉ định ban đầu.

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN CÁO LÂM SÀNG

Phác đồ phối hợp mang lại hiệu quả vượt trội trong việc kiểm soát nhiễm khuẩn huyết, giảm tỷ lệ tử vong nội viện từ 35% xuống còn 18.3%, là cơ sở tin cậy để chuẩn hóa phác đồ điều trị hồi sức cấp cứu.